Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Adenoidektomi

Geniz eti (adenoid) ameliyatı

Değerli hastamız, bu form size önerilen işlem hakkında bilmeniz gerekenleri **sade ve anlaşılır** bir dille anlatmak için hazırlanmıştır. Amacı sizi korkutmak değil, kararınızı **bilgiye dayanarak ve özgürce** vermenize yardımcı olmaktır.

Formu acele etmeden okuyunuz. Anlamadığınız her noktayı hekiminize sorunuz. Hekiminiz sizin durumunuza özel riskleri ayrıca sözlü olarak da açıklayacaktır. Onay vermek ya da vermemek tamamen sizin hakkınızdır.

HASTA VE İŞLEM BİLGİLERİ

Adı Soyadı: _____ Doğum tarihi: _____

T.C. Kimlik / Pasaport: _____ Dosya / Protokol No: _____

Telefon: _____ Bilgilendirme tarihi: _____

Planlanan işlem tarihi: _____

Form hastaya ilk iletildi (tarih / e-posta, WhatsApp, elden): _____

İşlemi yapacak ve bilgilendiren hekim: **Op. Dr. Murat Ayata**

İşlemin yapılacağı sağlık kuruluşu: _____

Aynı seansta yapılacak ek işlemler: ☐ Tonsillektomi (bademcik ameliyatı) ☐ Ventilasyon tüpü ☐ Yok _____

Ameliyat endikasyonu (hekim tarafından):
☐ Burun tıkanıklığı / horlama / uyku apnesi
☐ Orta kulak sıvısı / sık kulak iltihabı
☐ Tekrarlayan geniz eti iltihabı / sinüzit _____

Diğer / açıklama: _____

1 Durumunuz ve işlemin amacı

Geniz eti (adenoid), burnun arka kısmında, damağın üzerinde bulunan ve vücudun savunma sistemine ait lenf dokusudur. Özellikle 2–7 yaş arasındaki çocuklarda büyüyebilir; ergenlik döneminden itibaren genellikle küçülür.

Geniz eti büyüdüğünde burun arkasını tıkayarak **ağızdan nefes alma, horlama, uykuda nefes durmaları, burun akıntısı, genizden konuşma ve sık geçirilen enfeksiyonlara** yol açabilir. Kulak ile burun arkasını birbirine bağlayan östaki borusunun ağzını da tıkayabildiği için **orta kulakta sıvı birikimine, işitme azlığına ve tekrarlayan kulak iltihaplarına** neden olabilir. Uzun süren ağızdan solunum yüz ve diş gelişimini de etkileyebilir.

Adenoidektominin amacı, büyümüş geniz etini alarak burun solunumunu rahatlatmak ve kulak, sinüs ve solunum yolu şikâyetlerini azaltmaktır. Size veya çocuğunuza bu ameliyatın neden önerildiği hekiminiz tarafından ayrıca açıklanacaktır.

2 İşlem nasıl yapılır?

Ameliyat genel anestezi altında, ameliyathane koşullarında yapılır. Ağız içinden yapılır; **dışarıda herhangi bir kesi veya iz yoktur.**

1. **Hazırlık:** Anestezi verildikten sonra ağzı açık tutan özel bir alet yerleştirilir ve yumuşak damak hafifçe kaldırılarak burun arkası görülür.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2. **Geniz etinin alınması:** Geniz eti, özel bir kazıma aleti (küret), endoskop eşliğinde mikrodebrider, koblasyon veya koter gibi yöntemlerle burun arkasından alınır. Geniz eti tamamen bir organ değil bir doku olduğu için "kökünden" alınamaz; amaç tıkanıklığa yol açan kısmın güvenli bir şekilde çıkarılmasıdır.
3. **Kanama kontrolü:** Alınan bölgeye bir süre tampon/gazlı bez ile baskı uygulanır, gerekirse koter ile kanama durdurulur. Ameliyat bitiminde burun arkasında tampon bırakılmaz.
4. **Ek işlemler:** Planlandıysa aynı anestezi sırasında bademcik ameliyatı (tonsillektomi) veya kulak zarına ventilasyon tüpü takılması yapılır. Bu işlemler için ayrı onam formları doldurulur.
5. **Uyanma:** Ameliyat sonrası hasta, tamamen uyanana kadar derlenme odasında yakından izlenir.

Alınan doku, hekim gerekli görürse patolojik incelemeye gönderilir.

ANESTEZİ	TAHMİNİ SÜRE	HASTANEDE KALIŞ / TABURCULUK
Genel anestezi	Yaklaşık 20–30 dakika (anestezi süresi hariç)	Çoğunlukla aynı gün taburculuk; gerekirse 1 gece gözlem

3 Beklenen faydalar ve başarı şansı

- Burundan nefes almanın rahatlaması, horlama ve uykuda nefes durmalarının azalması
- Daha kaliteli uyku; buna bağlı olarak gündüz dikkat, davranış ve okul başarısında iyileşme
- Orta kulak sıvısı ve kulak iltihaplarının azalması, işitmenin düzelmesine katkı
- Burun akıntısı, sinüzit ve sık geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonlarının azalması

Uygun seçilmiş hastalarda burun tıkanıklığı ve horlama şikâyetleri büyük çoğunlukla belirgin şekilde düzelir. Ancak burun tıkanıklığının alerji, burun eti (konka) büyümesi veya septum eğriliği gibi başka nedenleri de varsa şikâyetler tamamen geçmeyebilir. Kulak sorunlarında başarı, östaki borusunun gelişimine de bağlıdır; bazı çocuklarda ek tedavi veya ventilasyon tüpü gerekebilir.

4 Diğer tedavi seçenekleri

- **Bekle-gör (izlem):** Şikâyetler hafifse, geniz eti yaşla birlikte küçüleceği için düzenli kontrollerle beklenebilir.
- **İlaç tedavisi:** Kortizonlu burun spreyleri bazı çocuklarda geniz eti şişliğini ve tıkanıklığı geçici olarak azaltabilir; alerji varsa alerji tedavisi yapılır. Etkisi genellikle ilaç kullanıldığı sürece devam eder.
- **Kulak sorunları için yalnızca ventilasyon tüpü:** Bazı durumlarda geniz eti alınmadan yalnızca kulak zarına tüp takılması düşünülebilir.
- **Uyku apnesi için diğer yöntemler:** Çok nadir durumlarda, cerrahinin uygun olmadığı hastalarda uykuda pozitif basınçlı solunum cihazı (CPAP) kullanılabilir.

5 İşlem yapılmazsa ne olur?

Ameliyat yapılmazsa geniz eti ergenlik döneminde kendiliğinden küçülebilir. Ancak o zamana kadar ağızdan nefes alma, horlama, kalitesiz uyku, tekrarlayan enfeksiyonlar ve kulakta sıvı birikimine bağlı işitme kaybı devam edebilir. Uzun süreli ve ağır uykuda solunum bozukluğu, çocuklarda büyüme-gelişme geriliği, dikkat ve davranış sorunları, nadiren kalp ve akciğer üzerinde yük oluşturabilir. Uzun süre devam eden orta kulak sıvısı, konuşma gelişimini etkileyebilir ve kulak zarında kalıcı değişikliklere yol açabilir.

Önerilen işlemi kabul etmeme, ertelemek isteme veya ikinci bir hekim görüşü alma hakkınız vardır. Bu kararınız, size sunulan diğer sağlık hizmetlerini hiçbir şekilde olumsuz etkilemez. Verdiğiniz onayı, işlem başlamadan önce istediğiniz zaman geri alabilirsiniz; ancak işlem başladıktan sonra tıbben durdurulması sakıncalı olabilecek aşamalar olabileceğini de bilmenizi isteriz.

6 İşlem öncesi hazırlık

- Ameliyattan önce kan tahlilleri (özellikle kanama-pıhtılaşma testleri) ve gerekirse diğer tetkikler yapılır; anestezi uzmanı tarafından değerlendirilirsiniz.
- Ailede kolay kanama, morarma veya kanama bozukluğu öyküsü varsa mutlaka bildiriniz.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Ameliyattan önceki **6 saat** boyunca katı gıda ve süt verilmemelidir; berrak sıvılar için anestezi uzmanının vereceği süreye uyunuz.
- Ameliyattan önceki 2–3 hafta içinde ateşli hastalık, ishal, öksürük veya grip geçirilirse lütfen bildiriniz; ameliyatın ertelenmesi gerekebilir.
- Sallanan süt dişi varsa anestezi sırasında düşme riski olduğundan hekiminize söyleyiniz.
- Çocuğunuzu ameliyata, yaşına uygun ve korkutmayan bir dille hazırlamanız önerilir.
- Kullandığınız **tüm ilaçları** (kan sulandırıcılar, aspirin, ağrı kesiciler, kilo verme ilaçları, hormon ilaçları dahil), **bitkisel ürünleri ve takviyeleri** (omega-3, E vitamini, ginkgo, sarımsak, ginseng, balık yağı gibi) hekiminize bildiriniz. Hekiminizin onayı olmadan kendi kendinize hiçbir ilacı kesmeyiniz.
- Bilinen **alerjilerinizi**, kanama veya pıhtılaşma sorunlarınızı, kalp, akciğer, şeker, tansiyon, tiroid gibi hastalıklarınızı, daha önce geçirdiğiniz ameliyatları ve anesteziyle ilgili sorunları mutlaka belirtiniz.
- Hamilelik ihtimaliniz varsa veya emziriyorsanız işlemden önce mutlaka söyleyiniz.
- Sigara ve nikotin ürünleri yara iyileşmesini belirgin şekilde bozar. Mümkünse işlemden en az 2–4 hafta önce bırakmanız ve iyileşme süresince içmemeniz önerilir.

7 İyileşme süreci: sizi neler bekliyor?

Ameliyat günü	Uyandıktan sonra hafif boğaz ağrısı, burunda kanlı-sümüksü akıntı ve ağızdan nefes alma olabilir. Kusma veya hafif ateş görülebilir. Bulantı geçtikten sonra önce su, sonra ılık ve yumuşak gıdalar verilir. Çoğu hasta aynı gün eve gider.
İlk 3–5 gün	Burun tıkanıklığı ve horlama ödem nedeniyle hâlâ devam edebilir; ağız kokusu, hafif ateş, kulak ağrısı ve boyun ağrısı olabilir. Ağrı genellikle hafiftir ve hekiminizin önerdiği ağrı kesicilerle kontrol edilir. Bol sıvı alınması önemlidir.
1. hafta	Çoğu çocuk 3–7 gün içinde okula/kreşe, yetişkinler işlerine dönebilir. Kalabalık ortamlardan ve enfeksiyonlu kişilerden ilk hafta uzak durulması önerilir.
2–4. haftalar	Ödem çözüldükçe burun solunumu belirgin olarak rahatlar. Geçici genizden konuşma (burundan kaçan ses) varsa bu dönemde düzelir. Yüzme ve ağır spor genellikle 2 hafta sonra serbesttir.
1–3. aylar	Kontrol muayenesi yapılır; kulak sorunu nedeniyle ameliyat olunduysa işitme testi ve timpanometri ile kulak durumu değerlendirilir.

8 Olası riskler ve komplikasyonlar

Her tıbbi işlemde olduğu gibi bu işlemin de bazı riskleri vardır. Aşağıda **beklenen geçici etkiler** ile **komplikasyonlar** ayrı ayrı ve görülme sıklıklarına göre gruplandırılmıştır. Verilen oranlar bilimsel yayınlara dayanan **yaklaşık** değerlerdir; sizin kişisel riskiniz yaşınıza, genel sağlığınıza, sigara kullanımına ve daha önce geçirdiğiniz ameliyatlara göre daha düşük ya da daha yüksek olabilir.

Komplikasyonların büyük çoğunluğu **geçicidir** ve uygun tedaviyle düzelir. Listede çok nadir görülen ciddi durumlara da yer verilmiştir; bunların yazılmış olması sizde görüleceği anlamına gelmez, ancak bilgilenmiş karar verebilmeniz için bilmeniz gerekir.

Beklenen, geçici etkiler (komplikasyon sayılmaz; iyileşmenin doğal parçasıdır)

- Hafif boğaz ağrısı, yutkunurken hassasiyet
- Burunda birkaç gün süren kanlı-sümüksü akıntı ve tıkanıklık
- Ağız kokusu (iyileşen yara yüzeyine bağlı, 1–2 haftada geçer)
- Kulağa vuran ağrı (aynı sinirlerden kaynaklanan yansıyan ağrı; kulakta bir hastalık olduğu anlamına gelmez)
- Hafif ateş (ilk 1–2 gün), anesteziye bağlı bulantı-kusma

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Sık görülen durumlar (çoğu geçicidir veya tedaviyle düzelir)

- **Geçici genizden konuşma** — Geniz eti alındıktan sonra damağın yeni duruma uyum sağlaması zaman alır; ses birkaç gün–birkaç hafta burundan kaçabilir veya sıvılar nadiren burundan gelebilir. Çoğunlukla 1–2 ay içinde kendiliğinden düzelir.
- **Boyun ağrısı ve tutukluk** — Ameliyat pozisyonuna ve burun arkasındaki iyileşmeye bağlı olarak ilk günlerde boynu hareket ettirirken ağrı olabilir; genellikle birkaç günde geçer.
- **Şikâyetlerin tamamen geçmemesi** — Alerji, konka büyümesi veya septum eğriliği gibi ek nedenler varsa burun tıkanıklığı kısmen devam edebilir; ek tedavi gerekebilir.

Seyrek görülen durumlar

- **Kanama** — Yaklaşık 100 hastadan **1'inden azında (yaklaşık 0,5–1)** ameliyattan sonra belirgin kanama görülür. Çoğu zaman ilk 24 saatte olur. Kanama durdurulamazsa **tekrar genel anestezi altında ameliyathanede kanamanın durdurulması** gerekebilir. Kan nakli ihtiyacı çok nadirdir.
- **Diş hasarı** — Ağzı açık tutan aletin baskısıyla, özellikle önceden sallanan veya çürük dişlerde, diş kırılması veya düşmesi olabilir.
- **Dudak, dil veya damakta yaralanma ve şişlik** — Aletlerin temasına bağlı küçük yaralar veya geçici şişlik görülebilir; birkaç günde iyileşir.
- **Enfeksiyon** — Ateşin yükselmesi, ağız kokusunun artması ve ağrının artmasıyla kendini gösterebilir; genellikle antibiyotikle düzelir.
- **Geniz etinin yeniden büyümesi** — Adenoid dokusu yeniden büyüyebilir (100 hastadan yaklaşık **1–5'inde**), özellikle çok küçük yaşta ameliyat edilenlerde ve alerjisi olanlarda. Şikâyetler tekrarlarsa nadiren yeniden ameliyat gerekebilir.

Nadir veya çok nadir, ancak ciddi olabilecek durumlar

- **Kalıcı genizden konuşma / sıvıların burundan gelmesi (velofaringeal yetmezlik)** — Yaklaşık **1.500–3.000 hastada 1** oranında görülür; özellikle damakta gizli yarık (submüköz damak yarığı) olan çocuklarda risk daha yüksektir. Konuşma terapisi ile çoğu zaman düzelir; nadiren düzeltici bir ameliyat gerekebilir. Bu nedenle damak muayenesi ameliyattan önce dikkatle yapılır.
- **Boyun omurlarında kayma (Grisel sendromu)** — Burun arkasındaki iltihabın boyun omurlarının bağlarını etkilemesiyle ortaya çıkan, **çok nadir** bir durumdur. Ameliyattan sonraki günlerde başlayan ve giderek artan boyun ağrısı, başı çevirememe ve başın yana eğik durmasıyla kendini gösterir. Erken fark edilirse ilaç ve boyunluk ile tedavi edilir; geç kalınırsa daha uzun süreli tedavi, nadiren cerrahi tedavi gerekebilir ve kalıcı boyun hareket kısıtlılığı kalabilir. Bu nedenle giderek artan boyun ağrısı mutlaka bildirilmelidir.
- **Burun arkasında yapışıklık veya daralma** — Çok nadiren, özellikle bademcik ameliyatıyla birlikte geniş doku alındığında, yara iyileşmesi sırasında burun arkasında daralma gelişebilir; burun tıkanıklığına yol açabilir ve ek tedavi gerektirebilir.
- **Ciddi kanama ve sonuçları** — Son derece nadir olarak, normal dışı seyreden bir damar veya bilinmeyen bir pıhtılaşma bozukluğu varlığında ciddi kanama gelişebilir. Bu durumda acil ameliyat, kan nakli ve **yoğun bakım** tedavisi gerekebilir; kanın solunum yoluna kaçması solunum sorunlarına yol açabilir.

Her cerrahi / tıbbi girişim için geçerli genel riskler

- **Anestezi riskleri:** Genel anestezi veya sedasyon uygulanacaksa riskleri (bulantı, boğaz ağrısı, diş hasarı, alerjik reaksiyon, çok nadiren kalp-akciğer sorunları) anestezi uzmanı tarafından ayrıca anlatılır ve **ayrı bir anestezi onam formu** ile onayınız alınır.
- **Kanama ve kan nakli:** Bu işlemlerde kan nakli ihtiyacı çok nadirdir. Ciddi bir kanamada kan veya kan ürünü verilmesi gerekebilir; bunun da kendine özgü (alerji, enfeksiyon gibi) çok nadir riskleri vardır.
- **Enfeksiyon:** Ameliyat sonrası yara enfeksiyonu genellikle antibiyotikle tedavi edilir; nadiren drenaj (iltihabın boşaltılması) gerekebilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Bacak toplardamarlarında pıhtı (DVT) ve akciğere pıhtı atması (pulmoner emboli):** Kısa süren baş-boyun ameliyatlarında çok nadirdir. Erken hareket etmek riski azaltır. Hormon ilacı kullanımı, sigara, obezite ve önceki pıhtı öyküsü riski artırır.
- **İlaç alerjisi:** Kullanılan ilaçlara, antiseptiklere, banda veya dikiş materyaline karşı alerjik reaksiyon gelişebilir.
- **Yara izi ve iyileşme sorunları:** Kişiden kişiye değişen iz oluşumu; çok nadiren kalın (hipertrofik) iz veya keloid gelişebilir.
- **Hayati risk:** Günümüzde planlı baş-boyun cerrahisinde ölüm son derece nadirdir; ancak hiçbir cerrahi girişimin riski tamamen sıfır değildir. Ciddi bir komplikasyon hâlinde yoğun bakım tedavisi gerekebilir ve kalıcı sakatlık gelişebilir.

Bu liste mümkün olan tüm komplikasyonları kapsamaz; tıpta öngörülemeyen, çok nadir başka durumlar da ortaya çıkabilir. Bir komplikasyon gelişirse, gerekli tedavi ve takip hekiminiz tarafından planlanır; bu durum ek tedavi, ilaç, girişim veya yeniden ameliyat gerektirebilir.

9 Hemen bize ulaşmanız gereken durumlar

- Ağızdan veya burundan **taze, kırmızı kan** gelmesi, kan tükürme veya kan kusma (birkaç damla dışında her kanama bildirilmelidir)
- Sık sık yutkunma (çocuklarda kanın yutulduğunu gösteren önemli bir belirti), solgunluk, halsizlik
- **38,5 °C üzerinde ateş**, ağrı kesicilere rağmen geçmeyen ateş
- Hiç sıvı içmeme, 6–8 saattir idrar yapmama, aşırı uykuya meyil (sıvı kaybı belirtileri)
- Giderek artan **boyun ağrısı**, başı çevirememe veya başın yana eğik durması
- Nefes almada zorluk, uykuda belirgin nefes durması

Bu durumlardan biri olursa bekletmeden hekiminizi arayınız: 0288 502 50 20 · WhatsApp 0555 333 21 20. Ulaşamazsanız en yakın acil servise başvurunuz veya 112'yi arayınız.

10 İlaçlar ve günlük yaşam ile ilgili öneriler

- Ağrı için yalnızca **hekiminizin önerdiği ağrı kesicileri** kullanınız; aspirin ve aspirin içeren ilaçlar kanamayı artırabileceğinden kullanılmamalıdır.
- İlk günlerde ılık-soğuk, yumuşak gıdalar ve **bol sıvı** tüketilmesi önerilir; çok sıcak, sert ve baharatlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır.
- İlk 1 hafta burun sert şekilde sümkürülmemelidir.
- Ameliyattan sonraki ilk hafta yurt dışı dönüş uçuşu planlanıyorsa, en erken ne zaman uçulabileceğini hekiminizle konuşunuz; kanama riski nedeniyle ilk günler hekime ulaşılabilecek bir yerde kalınması önerilir.
- Size reçete edilen ilaçları (antibiyotik, ağrı kesici vb.) önerilen doz ve sürede kullanınız. Aspirin ve benzeri kanamayı artırabilecek ilaçları hekiminize danışmadan kullanmayınız.
- Ameliyat sonrası 4 saatten uzun uçak veya kara yolculuğunda bol su için, sık sık hareket edin ve önerildiyse varis çorabı kullanın; bu, bacakta pıhtı riskini azaltır.
- İyileşme sürecinde alkol almamanız, sigara ve nikotin ürünlerinden uzak durmanız önerilir.
- Kontrol randevularınıza mutlaka geliniz. Yurt dışından geldiyseniz dönüşünüzden sonra kontroller online görüşme ve fotoğraf/video ile sürdürülebilir; yerel bir hekime başvurmanız gerekirse size ameliyat raporu ve önerilerimiz yazılı olarak verilir.

11 İşlem sırasında beklenmeyen durumlar, doku örnekleri ve kan ürünleri

İşlem sırasında önceden öngörülemeyen bir durumla karşılaşılırsa, hekiminiz yalnızca bu formda onay verdiğiniz işlemin kapsamında kalır. **Hayati tehlike veya ciddi organ zararı riski** olmadıkça onay vermediğiniz ek bir işlem yapılmaz; böyle bir durumda işlem uygun noktada sonlandırılır ve size sonradan bilgi verilerek karar birlikte alınır. Hayati tehlike durumunda ise hayatınızı veya organınızı korumak için gerekli acil müdahale yapılır.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

İşlem sırasında çıkarılan dokular, gerekli görüldüğünde tanının kesinleştirilmesi için **patolojik incelemeye** gönderilir. Bu inceleme sonucuna göre ek tedavi veya takip gerekebilir.

Kan nakli ihtiyacı bu işlemlerde çok nadirdir; yalnızca hayati gerekliliği olan durumlarda uygulanır. Kan veya kan ürünü almayı kabul etmiyorsanız (örneğin inanç nedeniyle) bunu işlemden önce mutlaka bildiriniz; bu kararın olası sonuçları sizinle ayrıca konuşulur ve "Size özel bilgiler" bölümüne yazılır.

12 Fotoğraf, görüntü kayıtları ve kişisel verileriniz

Tedavinizin planlanması, takibi ve sonucun değerlendirilmesi amacıyla işlem öncesinde ve sonrasında **fotoğraf/video** çekilebilir. Bu kayıtlar sağlık dosyanızın parçasıdır ve gizli tutulur. Görüntüleriniz **hiçbir koşulda reklam, tanıtım veya sosyal medya amacıyla kullanılmaz.**

Görüntülerinizin bunun dışındaki amaçlarla kullanılması **yalnızca sizin ayrı ve açık izninizle** mümkündür. İzin vermemeniz tedavinizi hiçbir şekilde etkilemez ve verdiğiniz izni dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz:

- ☐ Görüntülerimin yalnızca **tıbbi kayıt ve tedavi takibi** amacıyla kullanılmasını kabul ediyorum.
- ☐ Görüntülerimin **kimliğim anlaşılmayacak şekilde** (yüz/göz bölgesi kapatılarak) bilimsel yayın ve hekim eğitimi amacıyla kullanılmasına izin veriyorum.
- ☐ Görüntülerimin **kimliğim anlaşılabilecek şekilde** bilimsel yayın ve hekim eğitimi amacıyla kullanılmasına izin veriyorum.
- ☐ Bilimsel/eğitim amaçlı kullanıma **izin vermiyorum.**

Kişisel ve sağlık verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sağlık mevzuatı kapsamında, tanı, tedavi ve yasal yükümlülükler amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altındaki kişilerce işlenir. Ayrıntılı bilgi için KVKK Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.

13 Size özel bilgiler ve notlar (hekim tarafından doldurulur)

Hastaya özgü ek riskler (eşlik eden hastalıklar, kullanılan ilaçlar, önceki ameliyatlar), planın ayrıntıları, hastanın beklentisi, sorduğu sorular ve verilen cevaplar. Boş kalacaksa "yoktur" yazılır.

14 Hasta beyanı

- ☐ Bu formu kendi dilimde okudum, anladım. Yeterli düşünme süresi tanındı; sorularımı sorma fırsatı buldum ve tatmin edici yanıtlar aldım.
- ☐ Durumum, önerilen işlemin amacı, nasıl yapılacağı, kim tarafından ve nerede yapılacağı, tahmini süresi, beklenen faydaları, başarı şansı, alternatifleri ve işlem yapılmazsa olabilecekler bana sözlü ve yazılı olarak açıklandı.
- ☐ Sık görülen ve ciddi olabilecek riskler ile bu komplikasyonların olası sonuçları (ek tedavi, yeniden işlem/ameliyat gerekebileceği dahil) bana anlatıldı. Tıpta hiçbir işlemin sonucunun **%100 garanti edilemeyeceğini** biliyorum.
- ☐ Sağlık durumum, kullandığım ilaçlar, alerjilerim ve geçirdiğim hastalıklar hakkında doğru ve eksiksiz bilgi verdim. Eksik veya yanlış bilgi vermemin riskleri artırabileceğini biliyorum.
- ☐ İşlem öncesi ve sonrasında verilecek talimatlara uymamın sonucun bir parçası olduğunu ve kontrol randevularına gelmenin önemini anladım.
- ☐ Onayımı işlem başlamadan önce istediğim zaman geri alabileceğimi biliyorum. Bu formu imzalamamın, hekimin özen yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığını biliyorum.
- ☐ Bu kararı kimsenin baskısı olmadan, kendi özgür irademle veriyorum.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

☐ Ameliyattan sonraki ilk günlerde, özellikle çocuğum için, kanama belirtilerini (sık yutkunma, kan tükürme/kusma) takip etmem ve hekime ulaşmam gerektiği bana anlatıldı.

☐ **Yukarıda açıklanan işlemin bana uygulanmasına ONAY VERİYORUM.**

☐ **Yukarıda açıklanan işlemi KABUL ETMİYORUM. Reddetmenin olası sonuçları bana anlatıldı.**

Hasta tarafından kendi el yazısıyla yazılması önerilir: "Bu formu okudum, anladım, onay veriyorum."

15 İmzalar

	ADI SOYADI	İMZA	TARİH / SAAT
Hasta			
Yasal temsilci (veli / vasi) — yakınlığı:			
Bilgilendiren ve işlemi yapacak hekim			
Tercüman (gerekirse) — dil:			
Tanık (gerekirse)			

Tercüman beyanı: Bu formu ve hekimin sözlü açıklamalarını hastaya / yasal temsilciye eksiksiz ve doğru olarak, anladığı dilde tercüme ettim.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK VEYA KARAR VERME YETİSİ KISITLI HASTALAR İÇİN

18 yaşından küçük hastalarda onam, **veli veya vasi** tarafından verilir. Çocuk, yaşı ve olgunluğuyla uyumlu biçimde bilgilendirilir ve görüşü alınır. Kısıtlı hastalarda onamı yasal temsilci verir.

☐ Velayeti birlikte kullanıyorsak, diğer ebeveynin de bu işlemden haberdar olduğunu ve onay verdiğini beyan ederim.

☐ Velayet / vesayet konusunda bir mahkeme kararı veya anlaşmazlık bulunmadığını beyan ederim (varsa hekime belgesi gösterilmiştir).

Çocuğun yaşına uygun şekilde bilgilendirildiği ve görüşü: _____

Bu form iki nüsha olarak düzenlenmiştir: bir nüshası hasta dosyasında saklanır, bir nüshası hastaya / yasal temsilciye verilir.

ONAMIN GERİ ALINMASI (YALNIZCA VAZGEÇİLMESİ HÂLİNDE DOLDURULUR)

Yukarıda verdiğim onayı geri alıyorum. Vazgeçmemin olası sonuçları bana açıklandı.

Vazgeçen hasta/temsilci adı soyadı, imza, tarih, saat: _____

Bu form, T.C. Hasta Hakları Yönetmeliği ve Türk Tabipleri Birliği Aydınlatılmış Onam ilkeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Sözlü bilgilendirmenin yerini tutmaz, onu tamamlar.